دائرة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH

دليل
الرعاية العينية الأولية
للملاكات الصحية في مراكز الرعاية الصحيةالأولية

وزارة الصحة

دائرة الصحة العامة

قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

شعبة الصحة العينية والوقاية من العمى

وضعف البصر والصحة السمعية

٢٠٢٠

دليل
الرعاية العينية الأولية للملاكات الصحية في مراكز الرعاية الصحيةالأولية

اشراف

د.منى عطاالله خليفة علي

الطبيبة الاختصاص

مديرة قسم الوقاية والسيطرة على

الامراض غير الانتقالية

اعداد

د. زيد عبد النافع رضا / طبيب عيون

مدير برنامج الوقاية من العمى وضعف البصر

د. اياد عبد الحافظ/ طبيب عيون اختصاص

ابتسام عبدهامل/تقنيات طبية /اختصاص بصريات

معاون مدير برنامج الوقاية من العمى

المقدمة :-

يعتبر العمى من المشاكل الصحية المهمة التي تؤثر على المجتمع من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية. تؤكد التقديرات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية ان عدد المعاقين بصريًّا بنحو ٢٥٣ مليون شخص ، منهم ٣٦ مليونًا مصابون بالعمى. وان ٨٠% من حالات العمى يمكن تجنبها (يمكن علاجها و/أو الوقاية منها)
وقد أظهرت المسوحات العالمية إن من أهم مسببات العمى في العالم هي الإصابة بأخطاء الرؤية الانكسارية غير المصححة (Refractive Error) بنسبة ٤٢% ، والساد (الماء الأبيض، cataract) بنسبة ٣٣% . ثم داء الزرقاء Glaucoma. ، نقص فيتامين A (Deficiency Vitamin A) ، أمراض القرنية (corneal scars) واعتلال الشبكية السكري Diabetic Retinopathy

اما المسح الوطني لعوامل الخطورة للأمراض غير الانتقالية الذي تم تنفيذه في دوائر الصحة في المحافظات كافة في عام (٢٠١٥) تبين ان نسبة العمى في العراق هو(٠,٢%) كما وان نسبة ضعف البصر بلغت (٣,٥ %) وضعف البصر الشديد (٠,٨%).

تتمثل رؤيتنا في تحقيق عالم يخلو من أي شخص يعاني من ضعف البصر بواسطة حصول الجميع على خدمات شاملة لرعاية العين من خلال الحد من حالات ضعف البصر الذي يمكن تجنبه بوصفه مشكلة من مشاكل المجتمع.

غايتنا هي تحسين الحصول على خدمات شاملة لرعاية العين من خلال إدماج خدمات الرعاية العينية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية وإتاحة الفرص الكاملة لحصول المواطنين على تلك الخدمات مثل فحص عين الطفل قبل سن المدرسة، فحص عيون تلاميذ وطلاب المدارس ودور الدولة ، وفحص العيون والاكتشاف المبكر لمسببات العمى الممكن تجنيه وضعف البصر لكافة الفئات العمرية والاهتمام بكبار السن داخل المركز الصحي .

إن بناء وتنمية قدرات الملاكات الطبية والصحية والتمريضية العاملة في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات الرعاية العينية الأولية لكافة الفئات العمرية والمجتمعية وإدماج خدماتها ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوفير مستلزمات التدريب مع إعداد وطبع وتوزيع مواد توعية ودلائل لتدريب تلك الملاكات هي من الأهداف التي يسعى الى تحقيقها قسم الوقاية والسيطرة على الأمراض غير الانتقالية / شعبة الصحة العينية والوقاية من العمى والصحة السمعية والتي تركز على تقديم خدمات الرعاية العينية الاولية والوقاية من مسببات العمى الذي يمكن تجنبه وضعف البصر والتي هي احد الركائز المهمة في الرعاية الصحية الاولية .

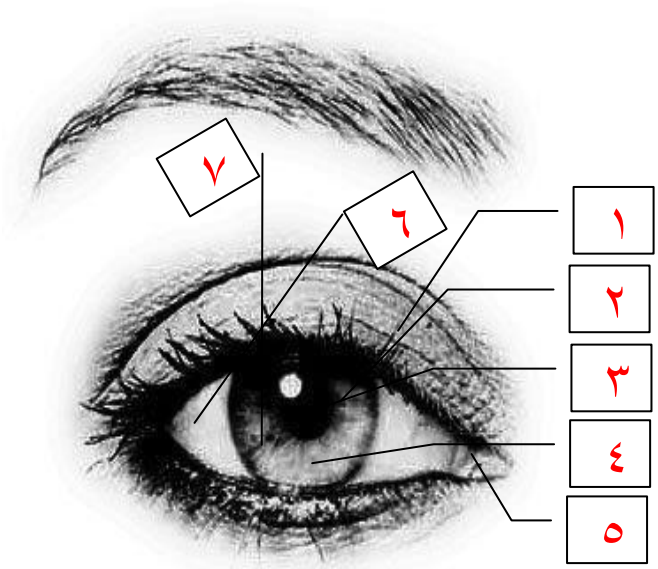
تم عرض دليل الرعاية العينية الاولية للملاكات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية امام انظار اللجنة الاستشارية لطب وجراحة العيون في وزارة الصحة ولامانع لديها من طبع الدليل وتوزيعه على مراكز الرعاية الصحية الاولية

نتمنى إن يحقق هذا الدليل التدريبي الأهداف المخطط لها عند إعداده .

ومن الله التوفيق

عين الإنسان لها خصوصيتها في التعامل عن سائر أعضاء الجسد، فهي الأكثر رقة وحساسية سواء من الجانب التشريحي أو الوظيفي

.اجزاء العين



١ – **الاجفان:** لحماية العينين من الاتربة والاوساخ او اي شئ خارجي مؤذي للعين.

٢ – **القرنية:** وهو عبارة عن طبقة رقيقة شفافة تغطي القزحية والبؤبؤ من العين.

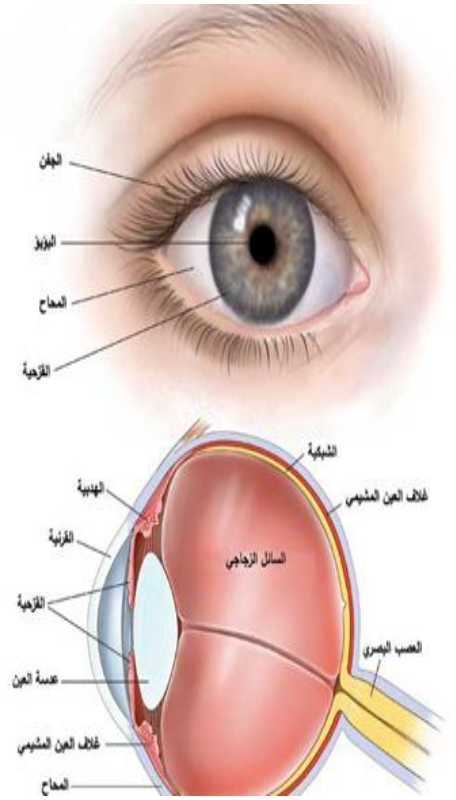
٣ – **البؤبؤ:** وهي الدائرة السوداء التي تقع في مركز العين والتي تسمح للضوء بالدخول الى العين.

٤–**القزحية:** وهو الجزء الملون المحيط بالبؤبؤ والذي يتغير حجمها نحو الاكبر عند فتحها او نحو الاصغر عند الاضاءة.

٥–**القناة الدمعية:** هناك فتحة صغيرة في نهاية القناة الدمعية تساعد على تنظيف العين وابقاءها رطبة دائما.

٦–**المنظمة:** وهي طبقة شفافة رقيقة تغطي بياض العين.

٧–**العدسة** : تعمل على تركيز الضوء قبل وصوله الى الشبكية عند الاشخاص الصغار تقوم العدسة بتغيير شكلها حتى تتمكن العين من رؤية الاشياء القريبة والبعيدة ايضاً وهذه العملية تسمى (التكييف) لملائمة



٨–الشبكية: هي الجزء الخلفي من العين والتي تحتوي على الخلايا التي تستجيب للضوء وهذه الخلايا تسمى مستقبلات الصور حيث تقوم باستقبال شعاع الضوء وتحويلها الى حوافز كهربائية . حيث تنتقل هذه الحوافز عبر العصب البصري الى الدماغ لكي تتحول الى صور

٩–**السائل الزجاجي:**. وهو سائل ثخين يملأ مركز العين ويعطي للعين الشكل والحجم.

١٠ – **العصب البصري:** ينقل الحافز الكهربائي من الشبكية الى الدماغ وهو يربط الجهة الخلفية من العين

الاكتشاف المبكر لإمراض العين الولادية والوراثية:-

يجب على طبيب الرعاية الاولية عند فحصه للأطفال ملاحظة مايلي :-

١- حجم وصفاء القرنية ، لاحتمال اصابة الطفل بداء الزرقاء الولادي اذا كانت قرنية العين كبيرة ومعتمة او عند عدم تساوي حجم القرنيتين .

٢- البؤبؤيين من حيث الشكل والحجم والتفاعل مع الضوء لاحتمال اصابة الطفل بفقدان القزحية ((Aniridia)) وتشوهات القزحية في مرض ريكر (Reiger anomaly) .

٣- وضع انعكاس الضوء على القرنيتين يفيد للاكتشاف المبكر لحالات الحول .

٤- حركة العينين ووجود حول واضح ، واحالة المصاب بالحول الى طبيب العيون لمعالجة كسل العين (Amblyopia) وضعف البصر واجراء تصحيح الحول .

٥- وجود رأرأة (Nystagmus) لدى الطفل خاصة المصاب بمرض البهاق (Albinism) وفقدان القزحية (Aniridia) وغيرها .

٦- انعكاس الضوء من قاع العين (red rflex) باستعمال الناظور (Ophthalmoscope)، فعدم ملاحظته قد يدل على وجود ساد ولادي او نزف داخل العين او عتمة القرنية ...

٧- وجود افراز قيحي شديد في العين قد يكون علامة على اصابة الطفل بجرثومة السيلان .

٨- وجود نزف تحت المنظمة لدى حديثي الولادة خصوصا اذا كانت الولادة متعسرة او تمت عن طريق استعمال الملقط .

٩- اذا اصيب الطفل برهاب الضوء(Photophobia) عند فحصه بمصدر ضوئي قد يدل على اصابة الطفل بداء الزرقاء الولادي او فقدان القزحية الوراثي.

- يحال الى طبيب العيون الاطفال المصابين بالحصبة لاحتمال اصابتهم بتقرحات القرنية ، والخدج الذين تم اعطاءهم كميات كبيرة من الاوكسجين غير مسيطر عليها ولفترات طويلة لاحتمال اصابتهم باعتلال الشبكية للخدج (Retinopathy of Prematurity)

الاجراءات :-

احالة المريض الى المستشفى .



فحص عين الطفل قبل سن المدرسة :-

يتم فحص عيون الاطفال حسب الفئة العمرية المشمولة بجدول اللقاحات الذين يراجعون مركز الرعاية الصحية الأولية لأخذ اللقاح ضمن البرنامج الموسع للتحصين.

اسأل الوالدين :

- هَلْ تبدو رؤية طفلكَ جيدةً؟ -
- عندما يحمل طفلك اللعبة هل يقرب او يبعد اللعبة عند التركيز ؟ -
- هَلْ عيون طفلكِ يَبْدو غير عاديةَ؟ -
- هل تبدو عيونُ طفلُكِ يَبْدو مستقيمةً أَو منحرفُة، أَو يَبْدو "كسولة"؟ -
- هَلْ جفون طفلكِ هاطلة أَو جفنُ واحد يَمِيلُ إلى الغَلْق؟ -
- هل هناك جرح في العين؟ -

Ask the parents:

- Does your child seem to see well?
- Does your child hold objects close to his or her face when trying to focus?
- Do your child's eyes appear unusual?
- Do your child's eyes appear straight or do they seem to cross, drift, or seem "lazy"?
- Do your child's eyelids droop or does one eyelid tend to close?
- Have your child's eyes ever been injured

نبحث عن:

- العين الحمراء-
- ورم الجفونِ.-
- عينين غير متناسقة او متساوية-
- رأرأة.-
- نتوء او جحوظ من عين واحدة أَو كلا العينينِ.-
- هطول الجفن.-
- شكل البؤبؤ(عادة مدّور) -

Look for:

- Eye redness or discharge.
- Swelling of the eyelids.
- Obvious signs of eye misalignment.
- Nystagmus.
- One or both eyes protrusion.
- Either eyelid droops.
- pupils shape (each have a round shape)



العلامات الخطرة:

تحتاج العيون إلى رعاية جيدة لأنها حساسة ، ويجب الحصول على المساعدة الطبية بسرعة عند أي حدوث أي من هذه العلامات الخطرة التالية:

١- أي إصابة يقطع أو تمزقات داخل مقلة العين

٢- الم ، بقعة رمادية على القرنية، مع احمرار حول القرنية

٣- ألام حادة داخل العين ((التهاب القزحية أو(الماء الأسود، glaucoma) داء الزرقاء))

٤- فرق كبير في حجم البؤبو ومصحوب بألم في العين أو الرأس



الاختلاف الكبير في حجم العينين من ربما يكون من تلف في الدماغ ، إصابات العين ، داء الزرقاء (الماء الأسود) أو التهابات القزحية .

٥- رؤية دم واحمرار خلف القرنية وداخل مقلة العين

٦- فشل الرؤية في واحدة أو كلتا العينين بشكل مفاجئ اوتدريجي

٧- توهج أبيض أو انعكاس في بؤبؤ العين يمكن أن يكون علامة على (سرطان الشبكية) أو الساد (الماء الابيض cataract)

٨- أية عدوى أو التهاب في العين لا يتحسن بعد (٥ أو ٦ أيام) اثناء العلاج مع مرهم مضاد حيوي العين

إصابات العين

يجب اعتبار جميع اصابات العين خطرة، لأنها قد تسبب العمى ، حتى الجروح الصغيرة في القرنية (الطبقة الشفافة التي تغطي البؤبؤ والقزحية) ربما تصاب بالالتهابات وتضر الرؤية اذا لم تعالج بشكل صحيح..واذا كان الجرح في كرة العين عميقة بحيث تصل إلى الطبقة سوداء تحت الطبقة البيضاء الخارجية ,وإذا كانت الإصابة حادة (كما هو الحال مع الشدة الخارجية) يتسبب في ملئ مقلة العين بالدم، وإذا كان الألم في العين حاد وفجأئي هو على الأرجح داء الزرقاء الحاد (الماء الاسود، glaucoma)

١- الأجسام الغريبــة :

قد تتعرض العين لدخول أجسام غريبة بها سواء كان ذلك داخل المنزل أو في موقع العمل ومن بين تلك الأجسام ما يلي

أ) جزيئات معدنية صغيرة

ب) نشارة الخشـــب

ج) الغبـــــار

د) الحصى الصغيـــرة



ما الذي ينبغي عمله في حالة الإصابة بجسم غريب بالعين؟

يتعين أخذ المصاب إلى الطبيب بأسرع ما يمكن حتى يتلقى العلاج اللازم.ويجب عدم دعك العين المصابة حيث أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى دفع الجسم الغريب ليخترق سطح العين والدخول إلى طبقة أعمق داخلها والذي قد يقلل من الألم بصفة مؤقتة إلا أنه يجعل عملية استخراجه أكثر صعوبة ويزيد من احتمال حدوث التهاب في العين

حماية العين من دخول الأجسام الغريبة بها ينبغي

ارتداء نظارات واقية عند التعامل مع المواد المتطايرة مع أخذ الاحتياطات اللازمة (عند تداول الرمال أو نشارة الخشب)

٢ – الإصابة بالمحاليل والمساحيق الكيماوية :

هناك أنواع عديدة من المحاليل الكيماوية التي يتم استخدامها بصورة يومية في كل بيت، مثل منظفات الغسيل والمطهرات وغيرها، وفيما يلي أمثلة لهذه المحاليل:

أ) المبيدات الحشرية .

ب) الدهانـات

ج) المنظفات الصناعية .

د) محاليل سامة أخرى مثل الكيروسين



ما الذي ينبغي عمله في حالة التعرض لإصابة كيماوية؟

تنتج عن طريق تعرض العين الى مادة حامضية او قاعدية اذ ينتج عنها الم شديد مع احمرار العين وهبوط حدة البصر .تسبب المواد القاعدية تلف في العين اكثر من الحامضية بسبب قدرتها على النفاذ خلال القرنية .

يجب اتخاذ اجراءات سريعة مثل غسل العين باي مصدر مائي نظيف او محلول السلاين لمدة ١٥–٣٠ دقيقة وقلب الاجفان وازالة اي مواد كيمياوية عالقة تحت الاجفان ومن ثم احالة المصاب باسرع وقت الى المستشفى

لحماية العين من الإصابة بالمحاليل الكيماوية:

يجب توخي الحذر وارتداء النظارات الواقية عند التعامل مع الكيماويات، كما ينبغي حفظ المحاليل بعيدا عن متناول أيدي الأطفال لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث.

٣ – إصابات العين النافذة :

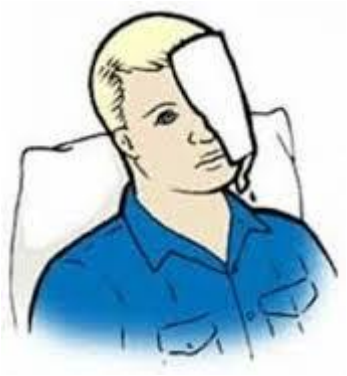
يمكن للأشياء التالية أن تسبب إصابات نافذة بالعين :

أ. الأسلاك

ب.أشواك الأشجار

ج.الألعاب ذات الأطراف المدببة والحادة

د. الأغراض المدببة والحادة التي تستخدم عادة في المطبخ أو الحديقة.



ما الذي ينبغي عمله عند التعرض لإصابة نافذة بالعين؟

يجب تغطية العين بشاش نظيف وذلك بعد إغلاق الجفن ثم ارتداء نظارات واقية والإسراع إلى الطبيب لتقي العلاج اللازم.

للوقاية من إصابات العين النافذة :

يجب توخي الحذر عند التعامل مع الأدوات الحادة ويجب إبعاد هذه الأشياء عن متناول أيدي الأطفال.

٤ – الإصابات السطحية (الخارجية) بالعين:

يمكن للأشياء التالية أن تسبب إصابات سطحية (غير عميقة) بالعين:

أ. التعرض لوهج اللحام .

ب.أصابع اليـد .

ج. الأغراض غير الحادة أو غير مدببة الأطراف.



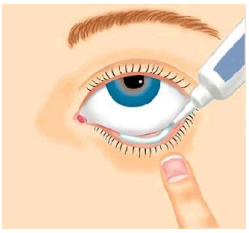
ماالذي ينبغي عمله عند التعرض لإصابة خارجية بالعين؟

ينبغي تغطية العين المصابة بشاش نظيف. تأكد من أن الجفن لا يمكنه الحركة تحت الغطاء. والغرض من وضع الغطاء هو تقليل الألم المصاحب لحركة جفن العين على سطح القرنية المصابة، حيث أن استمرار الحركة على القرنية المصابة من شأنه أن يؤخر نمو الخلايا الجديدة ومن ثم يؤخر عملية الشفاء .وينبغي رؤية الطبيب.

كيفية وقاية العين من الإصابات الخارجية:

– يجب ارتداء النظارات الواقية عند استخدام أدوات اللحام وعدم النظر بصورة مباشرة إلى وهج اللحام أو الشمس، وفي كافة الأحوال يجب أن نتوخى الحذر عند قيامنا بالأعمال والأنشطة اليومية حتى لا نلحق الضرر بالعين

– اتخاذ الاجراءات والاسعافات السريعة في حالة اصابات العيون علما ان المستشفيات التي تقدم خدمات الرعاية العينية تعمل بنظام الاحالة لذا فالوقت جدا مهم في معالجة تلك الاصابات قبل الوصول الى المستشفى (قد تكون اصابة العين غير نافذة مثل اصابة العين بكرة اوبقبظة اليد او شريط مطاطي او تكون نافذة بواسطة اجسام حادة عن طريق القرنية او الصلبة وقد تكون مصحوبة بدخول اجسام غريبة الى داخل العين) .لاسعافات تكون بوضع قطرة مضاد حيوي في العين وتغطية العين بقطعة من الشاش الطبي واحالة المصاب الى المستشفى



في حالة الحروق الحرارية

- يوضع مضاد حيوي وتغطى العين بقطعة شاش ويحال المصاب الى المستشفى . لتقييم حالة العين والنظر في اتخاذ اجراءات جراحية اخرى



كيف تُزيلُ الاجسام الغريبة منْ العين؟

- يمكنك في أحيان كثيرة إخراج ذرَّة غبار أو حَبَّة رَمْل من العين بغمرها بالماء النظيف، أو باستخدام طرف منديل نظيف جدًّا، أو طرْف قطعة من القطن رطبة.
- وإذا كانت ذرَّة الغبار تحت الجفن العلوي، فابحث عنها بثني الجفن إلى أعلى بالاستعانة بعود رفيع.

(أ) اغمر العين بماءٍ دافئٍ (لطيف الحرارة) في الحال.

(ب) اثن الجفن إلى أعلى بعودٍ رفيعٍ.

(ج) كثيرًا ما توجد ذرة الغبار في زاوية قرب حافة الجفن، فأزلها بركن منديل نظيف جدًا أو عود قطني نظيف.

التهاب الملتحمة (conjunctivitis)

التهاب الملتحمة:وهو التهاب غشاء الملتحمة الذي يبطن الجفون وجزءاً من مقلة العين تصاب إحدى العينين أو وتُشخص التهاب الملتحمة إلى نوعين كلتاهما بإحمرار وحكة وقد يرافق ذلك رؤية ضبابية وحساسية تجاه الضوء .

من الالتهاب

- التهاب حاد : هو أكثر الالتهابات التي تصيب العين ويتسبب به الفيروسات أو البكتيريا
- التهاب مزمن : هو التهاب عين يتسبب عن تحسس أو أي مواد مهيجه من البيئة المحيطة يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر وهذا يعتمد على طول مدة استمرار الحالة أو الالتهاب وعلى حدة الأعراض بالإضافة إلى نوع الميكروب الذي أصيبت به الملتحمة

ويمكن أن يصيب الالتهاب عين واحدة أو كلا العينين، وإذا كان سبب الإصابة العدوى فمن السهل انتقال الالتهاب من عين إلى الأخرى بمجرد لمس العين المصابة ثم لمس العين السليمة وخاصة بين الأطفال

أسباب المرض

يمكن أن ينتج التهاب الملتحمة عن بكتيريا أو فيروسات أو عوامل بيئية مثل الحساسية لأدوات التجميل أو حبوب اللقاح أو مسببات الحساسية الأخرى ، و كثيراً ما يحدث التهاب الملتحمة الفيروسي بعد نزلة برد أو عدوى فيروسية أخرى لأعلى الجهاز التنفسي و التهاب الملتحمة البكتيري معد بشكل كبير ، و ينتشر بسهولة عندما يحك الناس أعينهم بأصابعهم ، و هو شائع بشكل خاص بين الأطفال في المدارس و دور الحضانة ،التهاب ملتحمة حديثي الولادة يصيب الأطفال أثناء الولادة إذا كانت الأم قد أصابها (الهربس) أوالسيلان ، ويمكن أن ينتشر هذا النوع من التهاب الملتحمة خلال العين كلها مسبباً العمى ما لم يعالج فوراً لذا فاعطاء مرهم التتراساكلين لعيون الاطفال بعد الولادة مباشرة في المستشفيات والمراكز الصحية التي تتوفر فيها صالات ولادة .

الاعراض

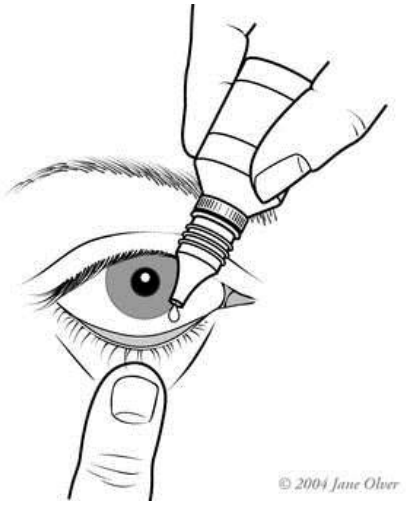
- ♦ احمرار في عين واحدة أو كلتا العينين
- ♦حكة في عين واحدة أو كلتا العينين.
- ♦تشوش في الرؤية وحساسية للضوء
- ♦الشعور بوجود رمل أو جسم غريب ولا تستطيع إزالته في عين واحدة او كلتا العينين،
- ♦زيادة افراز الدموع
- ♦افرازات قشرية في عين واحدة أو كلتا العينين أثناء الليل
- ♦يجد الكثير من الناس الذين لديهم التهاب الملتحمة مشكلةً في فتح أعينهم في الصباح بسبب الافرازات المتجففة على الجفون.





انواع التهابات المنظمة

١-التهاب المنظمة الصديدي (بكتيري)
٢-التهاب المنظمة الحبيبي (فيروسي)
٣ -التهاب المنظمة الربيعي (التحسّسي)



•الطريقة السليمة لاستخدام قطرة العين:

يتم شد الجفن السفلي للعين ثم توضع في منتصف الجفن السفلي ١-٢ نقطة (مع محاولة عدم لمس علبة القطرة للعين) ثم تفتح و تغلق العين بلطف لانتشار القطرة

الوقاية ومنع انتشار التهاب الملتحمة

- غسل الأيدي والوجه باستمرار بالماء الدافئ و الصابون.
- تجنب استخدام المناشف المشتركة.
- إزالة إفرازات العين بمنديل نظيف ثم التخلص منه.
- عدم استخدام قطرات أو مراهم مشتركة مع شخص أخر.
- تجنب ملامسة أنبوبة المرهم أو القطرة للعين.
- غسيل الأيدي جيدا بعد استعمال القطرات و المراهم.
- عدم استخدام القطرة التي استعملت للعين المصابة للعين الأخرى السليمة.
- لا يتم استخدام العدسات اللاصقة حتى يتم الشفاء تماما.
- عدم استخدام أدوات مكياج العين حتى يتم الشفاء تماما.





الوقاية خير من العلاج

يمكن للعادات الصحية الشخصية الجيدة أن تقلل من خطر التعرض للإصابة بالتهاب الملتحمة أو نقله ، لا تلمس عينيك بيديك ، و علم أطفالك أن يتجنبوا ذلك أيضاً ، اغسل اليدين كثيراً ، تجنب المشاركة في المناشف و أدوات الاستحمام و أدوات تجميل العين ، لا تسبح في نفس الماء مع شخص مصاب ، تجنب الأجواء الحارة والأشعة الزائدة ، لا تلمس اجسام (مثل المناشف أو الأنسجة) التي لمسها الشخص المصاب، فكلها يمكن أن تنشر العدوى ، واتق التهاب الملتحمة التحسسي بتجنب المواد التي سببته لك في الماضي ، مثل نوع معين من الماسكرا أو محلول تنظيف العدسات اللاصقة .

و يمكن منع التهاب الملتحمة لحديثي الولادة بالرعاية الجيدة قبل الولادة و رعاية حديث الولادة ، و ينبغي فحص النساء الحوامل من أجل معرفة الأمراض المنقولة جنسياً ، و علاجها إن لزم ، و يمكن لعلاج المولودين حديثاً بمرهم التتراساكلين للعين ، و هو نظام متبع في أقطار كثيرة ومنها العراق ، لانه يقي من المرض كذلك

يحتفل العالم والعراق بالقضاء نهائيا على مرض التراخوما في٢٠٢٠

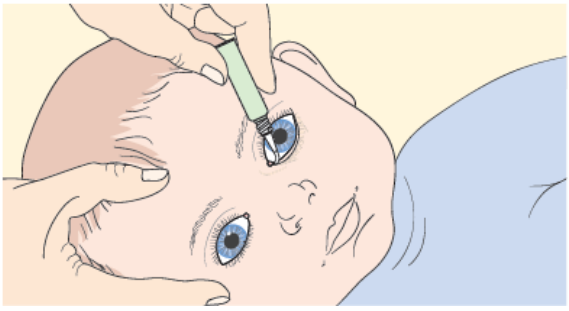
النظافة تساعد على منع التراخوما.

العيون المصابة في الأطفال حديثي الولادة

التهاب الملتحمة(NEONATAL CONJUNCTIVITIS)

إذا كانت الأم تعاني الكلاميديا أو السيلان فان هذه العدوى إلى سوف تنتقل الى طفلها عند الولادة. ويمكن أن يسبب العمى ومشاكل صحية أخرى. إذا كنت عيون الطفل حمراء ، وفيها تضخم، والكثير من القيح فيها خلال الشهر الأول، فانها العدوى. من المهم توفير العلاج فورا .

- علاج السيلان وإعطاء الأدوية على راي الطبيب المعالج
- تنظيف عيني الطفل. وضع (مرهم العين التتراسيكلين ١٪) في كل من عيني الطفل خلال الساعات الأولى بعد الولادة داخل صالات الولادة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية التي تتوفر فيها صالات ولادة.



التهاب القزحية

العلامات:-:

-البؤبؤ صغير

- التهاب القزحية



احمرار حول القزحية

- ألم شديد

التهاب القزحية يحدث عادة في عين واحدة فقط. الألم قد يبدأ فجأة أو تدريجيا. تدمع شديد. يزداد الالم أكثر في الضوء الساطع. الم في مقلة العين عند لمسها. ليس هناك صديد كما هو الحال مع التهاب الملتحمة. عادة عدم وضوح الرؤية .تعتبر حالة طارئة. المراهم والمضادات الحيوية لا تساعد.

الحصول على المساعدة الطبية بالاحالة الى طبيب العيون فوراً

داء الزرقاء(الماء الاسود، Glaucoma)

هو مرض خطير يحدث نتيجة زيادة في ضغط العين. يبدأ عادة بعد سن الاربعين وهو احد مسببات العمى. ، فمن المهم التعرف على علامات الزرق والحصول على المساعدة الطبية بسرعة .

هناك نوعان من الماء الاسود:-

١-داء الزرقاء الحاد

يبدأ فجأة مع صداع أو ألم شديد في العين.

تصبح العين حمراء،

عدم وضوح الرؤية.

مقلة العين تصبح قوية عند لمسها، مثل الحجر. أحيانا هناك قيء. البؤبؤ للعين المصابة أكبر من العين الطبيعية .

إذا لم يعالج بسرعة، قد يسبب داء الزرقاء الحاد العمى في غضون أيام قليلة. وغالبا ما تحتاج إلى جراحة.



يجب إحالة المصاب بالماء الاسود إلى طبيب العيون بسرعة .

٢- داء الزرقاء المزمن

يرتفع ضغط العين ببطء. عادة لا يوجد ألم. يتم فقدان الرؤية ببطء، بدءا من جوانب الرؤية المحيطية وغالبا لايلاحظ الشخص ذلك الفقدان ، اختبار الرؤية الجانبية والمحيطية قد تساعد في الكشف عن المرض .

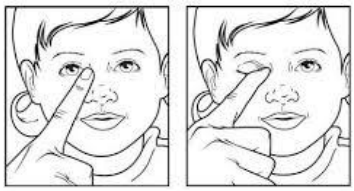
العلاج

- الاكتشاف المبكر للمرض،
- العلاج وحسب راي طبيب العيون بقطرة خاصة تقلل من ارتفاع ضغط العين قد تمنع العمى.
- قياس ضغط العين بشكل دوري خاصة للفئة العمرية (اكبر من ٤٠ سنة)
- عمليات العيون الجراحية .

الوقاية:

يجب فحص ضغط العين مرة واحدة في السنة على الاقل للأشخاص الذين هم أكثر من ٤٠ سنة أو الذين هم مصابين بداء الزرقاء (الماء الاسود، Glaucoma)

التهاب كيس الدمع (SAC TEAR)



العلامات :

احمرار، ألم، وتورم تحت العين، بجانب الأنف. تدمع .تقيح في زاوية العين عند الضغط على التورم بلطف .

العلاج :

- ♦ وضع كمادات ساخنة .
- ♦ العلاج وحسب راي طبيب العيون ، وضع قطرات العين أو مرهم مضاد حيوي في العين .

تغيرات في البقعة الصفراء Age-related macular degeneration

هو احد الاسباب الرئيسية للعمى خاصة في البلدان الغربية ، وهو يصيب كلتا العينين وتصاب العين الاولى في عمر(٦٥ سنة) بالمعدل .

الاعراض :

- هبوط شديد في الرؤية المركزية قد تكون مصحوبة بتغيير في رؤية الالوان .

العلامات :-

- تغير في منطقة البقعة الصفراء .

الفحوصات

- فحص حدة البصر
- البؤبؤ طبيعي ويتفاعل مع الضوء
- فحص الالوان غير طبيعي
- فحص قاع العين بالناظور

الاجراءات :

١- احالة المريض الى المستشفى لاستكمال الفحوصات والمعالجة .
٢- متابعة المريض في فترات منتظمة .

اعتلال الشبكية السكري Diabetic retinopathy :-

وهو من الاسباب المهمة للعمى وضعف البصر .
اما اسباب ضعف الرؤية عند الاصابة باعتلال الشبكية السكري فهي :

- وذمة البقعة الصفراء .
- نزف السائل الزجاجي .
- انفصال الشبكية .
- داء الزرقاء
- الساد .

ان اعتلال الشبكية السكري يصيب العينين ولكن بصورة غير متساوية . ويتخذ المرض بصورة عدة صور منها **الاعتلال غير التكاثري** الذي يظهر على شكل بقعة نزفية على سطح الشبكية ، انتفاخات على سطح الاوعية الدموية الدقيقة (micro aneurysm) ، ترسبات دهنية صفراء اللون (hard exudates) قد تاخذ اشكال حلقية او وذمة البقعة الصفراء .
اما **الاعتلال التكاثري** تتكون اوعية دموية جديدة على العصب البصري او الشبكية وقد تنزف هذه الاوعية في السائل الزجاجي او امام الشبكية وقد تتكون نتيجة لذلك اغشية وعائية ليفية تسبب تقلصها انفصال الشبكية . ان المراحل المبكرة للاعتلال الشبكية السكري قد لاتحتاج الى علاج وينصح المريض بالسيطرة على نسبة السكر في الدم ، ونسبة الكوليسترول ، ضغط العين ، ووظائف الكليتين ، ولكن في المراحل المتقدمة قد يحتاج المريض الى علاج بالليزر ، زرق ادوية خاصة في السائل الزجاجي وتثبيت الشبكية .

الاعراض:-

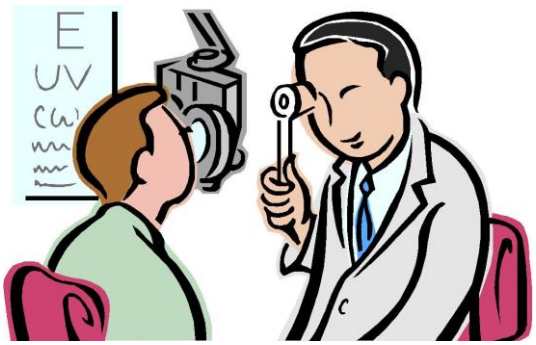
- رؤية مشوشة وفقدان البصر بشكل تدريجي.
- رؤية بقع أو "الذبابة الطائرة".
- ظلال أو مساحات يفقد فيها البصر.
- صعوبة للرؤية ليلا.

العلامات نقصان لحدة النظر و يحدث عادة بشكل مفاجيء.

الفحوصات

يمكن لاعتلال الشبكية السكري أن يمسّ بالبقعة الصفراء (المنطقة المركزية للشبكية المسؤولة عن الرؤية الدقيقة) أو بمحيطها. وفق المنطقة المصابة ودرجة تقدم المرض، للأخصائيين خيارات علاج مختلفة مثل الليزر، والحقن داخل الجسم الزجاجي أو الجراحة أما غيرها من المضاعفات المرتبطة بالسكري، مثل داء الزرق (الجلوكوما) أو مرض الساد، فهي تستدعي علاجات خاصة.

الاجراءات :يجب على مرضى السكري الخضوع إلى مراقبة صارمة لمستوى السكر في الدم وضغط الدم. هنالك عوامل أخرى تنعكس سلبا على اعتلال الشبكية السكري مثل السمنة أو التدخين. ويحتاج هؤلاء المرضى إلى فحوص منتظمة للشبكية بما أن اعتلال الشبكية السكري لا يولد أعراضا حتى يصبح الضرر حادا.





صعوبة الرؤية

الأطفال الذين لديهم صعوبة في الرؤية بوضوح أو الاشخاص الذين لديهم صداع أو ألم في العين عند القرأة قد تحتاج النظارات.

يجب فحص اخطاء الرؤية الانكسارية

إما الاشخاص الذين اعمارهم اكثر من اربعين سنة فتصبح رؤية الأشياء القريبة غير واضحة ا لذا يجب ارتداء نظارات مناسبة للرؤية القريبة والقراءة. اختيار النظارات التي تتيح لك رؤية واضحة حوالي ٤٠ سم. بعيدا عن عينيك.

يحال ضعاف البصر الى اختصاصي البصريات او فاحص البصر لوصف النظارات الطبية المناسبة

تعاريف

- **حدة البصر**: هي قدرة العين على تمييز شكل وتفاصيل الاجسام فالعين السوية هي التي تستطيع ان تركز اشعة الضوء الساقطة عليها في بؤرة حادة في شبكية العين تدعى الشائبة الصفراء
- **ضعف البصر** : هو قلة حدة البصر والمكتشف على لوحة فحص البصر باقل من ١٨/٦ وفي كلتا العينين وبعد التصحيح بالنظارات .
- **العمى** : هو عدم القدرة على عد الاصابع من بعد اقل من ثلاثة امتار

تصنيف منظمة الصحة العالمية لحدة البصر لقياس ضعف البصر والعمى :-

من	الى	التشخيص
٦/٦	١٨/٦	طبيعي
اقل من ١٨/٦	٦٠/٦	ضعف بصر
اقل من٦٠/٦	٣/٦٠ او عد الاصابع من بعد ٣ امتار	ضعف بصر شديد
اقل من ٣/٦٠	عدم التحسس بالضوء	الاعمى

ملاحظة النقاط التالية :-

- درجة الرؤيا مع التصحيح بالنظارات .
- اقل من ١٠ درجات (الرؤيا المحيطية) يساوي العمى
- 6/18 > الى 3/60 يدعى أحيانا البصر الضعيف (Low vision)



اخطاء الرؤية الانكسارية Refractive errors :-

ان العين الطبيعية تملك قوة انكسارية للضوء يؤدي الى تجمع الاشعة الضوئية على الشبكية ، وفي حالة عدم توافق قوة العين الانكسارية مع طول العين تتجمع الاشعة اما امام او خلف الشبكية مسببة ضعف في البصر .

وتشمل اخطاء الرؤية الانكسارية مايلي :-

- قصر البصر Myopia :-

حيث تملك العين قوة انكسارية كبيرة وتسقط الأشعة الضوئية إمام الشبكية فكون الأشياء القريبة إلى العين أوضح وتصحح بالعدسات المقعرة.

- بعد البصر Hypermetropia :-

تكون القوة الانكسارية للعين ضعيفة وتسقط الأشعة الضوئية خلف الشبكية وفيها يضطر المريض إلى ابعاد الاشياء لرؤيتها بوضوح وتصحح بالعدسات المحدبة .

- حرج البصر Astigmatism :-

هو اختلاف في تحدب القرنية تقل الرؤية عند النظر للقريب او البعيد .

- قصو البصر الشيخوخي presbyope :-

ويحدث عادةً بعد سن الاربعين عندما تبدا رؤية الاشياء القريبة بعدم الوضوح خاصة في القراءة والخياطة فيبدا الشخص بابعاد الكتاب اكثر من المعتاد لرؤية الاحرف بوضوح . تعالج هذه الحالة الطبيعية بالعدسات الطبية المكبرة



ضعف البصر

قد يدلل وجود الاعراض والعلامات التالية لدى المصاب على وجود خطأ انكساري ومن الممكن تدريب الملاكات التربوية بخصوص ملاحظة الطلبة من اجل الاستدلال على وجود تلك الاعراض والعلامات لغرض احالة الطالب المصاب الى مركز الرعاية الصحية الاولية وحسب الرقعة الجغرافية او وحدات الرعاية العينية المجتمعية من اجل فحص حدة البصر وتحديد نوع الخطأ الانكساري ووصف النظارات المناسبة.

اعراض من لديه خطأ انكساري:

- إحمرار الجفن
- إحمرار المنظمة .
- تدمع العين
- يفرك المصاب عينيه في اكثر الاحيان .
- يحاول ان يغمض عينيه ويفتحها لمشاهدة الصور بوضوح
- يتهيج عصبيا ويصرخ بعض الاحيان عندما لايرى الاشياء بوضوح .
- عندما ينظر الى الاشخاص او المناظر البعيدة ياخذ الاوضاع التالية :-

* يقطب وجهه.
* يضغط على نفسه ويحدق بعينيه ليرى الصورة.
* يقدم رأسه الى الامام .

- في حالة الطلبة او المصابين الذين لا يستطيعون القراءة عندما يعطوه شيْ للقراءة نراهم ياخذون الاوضاع التالية:

* يرمش اجفانه باستمرار.
*يمسك الكتاب بعيدا او قريبا من الوجه وحسب نوع الخطأ الانكساري .
*يظهر عليه عدم الراحة .
*يغمض عينيه او يغطيها بيده بعض الاحيان.
* يحرك رأسه الى احدى الجهات .
* عينيه تنحرف بصورة غير طبيعية .
* يحاول تبديل وضع الكتاب ليرى بوضوح.



أسباب ضعف البصر :

أ- ضعف البصر الناتج من الأمراض العينية مباشرة وتشمل :

١- التهابات في أجزاء العين وخاصة التهابات القرنية والقزحية والشبكية والتهابات الملتحمة الخطيرة خاصة التهاب المنظمة الصديدي والحبيبي .

٢- عتومة القرنية.

٣- الساد (الماء الابيض ، Cataract)

٤- اعتلال الشبكية السكري

٥- داء الزرقاء (الماء الاسود ، Glaucoma)

ب- ضعف البصر الناتج من اخطاء الرؤية الانكسارية .

١- قصر النظر .

٢- بعد النظر .

٣- الاستكماتزم .

٤- الحول .







- **وصف النظارات الطبية الملائمة وتدريب المريض على كيفية استخدامها والعناية بها.**

- إذا كانت النظارة هي الحل الْمُوصَى به لمشكلة الطالب، فسيقوم بصنعها أخصائي البصريات، (بعد التأكد من أن يرى بها أحسن من الرؤية بدونها).
- ويجب أن تصدر تنبيهات صارمة بشأن:

(أ) المحافظة على نظافة العدستين والإطار بغسلها يوميًّا .

(ب) المداومة على لبس النظارة إلا أثناء الرياضة إذا كان في ذلك مُخاطرة أو أثناء النوم،

(ج) قابلية النظارة للكَسْر.

(د) يجب إعادة فحص البصر مرة كل سنة او سنتين .



فحص حدة البصر باستخدام لوحة فحص البصر (Snellen Chart) .

تعليمات حول قياس حدة البصر

١. توضع لوحة الفحص على الحائط وبنفس مستوى النظر او اعلى قليلاً في غرفة مضيئة مقابل الشباك وليس بجانبه لان الضوء سوف يلمع في عين الشخص المفحوص ويؤثر على الفحص .
٢. يجب ان يقف المفحوص على بعد ستة امتار من اللوحة او ثلاثة امتار في حالة وجود مرآة وتثبت لوحة الفحص خلفه.
٣. ابدا بالفحص دائما بالعين اليمنى ، ثبت النتيجة ، ثم افحص العين اليسرى .
٤. غط العين الثانية بغالق العين او ورقة سميكة مع مراعاة عدم الضغط الشديد .
٥. التأشير اسفل الحرف المراد معرفته بعصا او قلم مغاير للون اللوحة ويجب ان يؤشر الشخص المفحوص بيده على اتجاه الحرف او الفتحة ولا تعتمد على كلمة يمين او يسار لانه ربما يخطا بين اليمين واليسار.
٦. كن صبورا ومشجعاً اثناء الفحص ، معظم الاطفال والتلاميذ وحتى الكبار يخافون الفحص كما في الامتحان او خوفا من النظارات يحاولون الغش والنظر خلال الاصابع ، قربه من لوحة فحص البصر واشرح له الموضوع ابدا دائما من الحرف الكبير وانزل تدريجيا فهو اسهل للنظر وحتى يتعود على الفحص ثم ارجعه الى مسافة ستة امتار .
٧. لتثبيت حدة البصر يجب ان يرى اكثر من نصف الاحرف في السطر ، وان رأى اقل من نصف الاحرف ثبت درجة السطر الذي سبقه .
٨. الدرجة ٦/٦ البسط ثابت ويمثل المسافة ستة امتار بين الشخص المفحوص واللوحة ، اما المقام فهو متغير حسب قوة النظر .
٩. حدة البصر التي ١٨/٦ فما دون يحتاج احالة الى وحدات الرعاية العينية المجتمعية او مستشفى قريب لفحص اخطاء الرؤية الانكسارية ووصف النظارات الطبية.
١٠. يتم استخدام الفحص بالناظور الشبكي(RetinoScope) او(Autorefractometer) لتحديد الخطأ الانكساري وتصحيحه بالعدسات الملائمة ويتم وصف النظارت الطبية المناسبة حيث تكون العدسات محدبة في بعد البصر ومقعرة في قصر البصر واسطوانية في حرج البصر (الاستكماتزم) وقد يكون هناك حرج البصر مع بعد البصر او قصرالبصر ويتم فيها وصف العدسات لكلتا الحالتين
١١. اخطاء الرؤية الانكسارية والحول الذي يصيب عين واحدة ان لم تعالج قبل السابعة من العمر سوف يؤدي الى كسل وظيفي في العين المصابة ولا يمكن الحصول على نظر طبيعي بعد ذلك

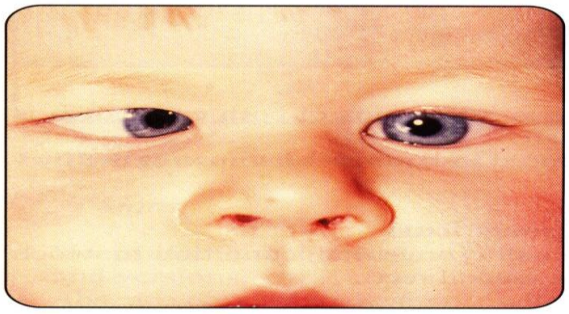


الحول squint : انحراف العين عن وضعها الطبيعي بسبب اختلال توازن عضلات العين

اسباب الحول :

- اسباب وراثية .
- النوع الشللي ويتسبب عن شلل احدى او مجموعة العضلات المحركة للعين .
- نوع انكساري ناتج عن اخطاء الرؤية الانكسارية من الممكن اصلاحها اما جراحيا او بالنظارات

اخطاء الرؤية الانكسارية والحول الذي يصيب عين واحدة ان لم تعالج قبل السابعة من العمر سوف يؤدي الى كسل وظيفي في العين المصابة ولا يمكن الحصول على نظر طبيعي بعد ذلك.



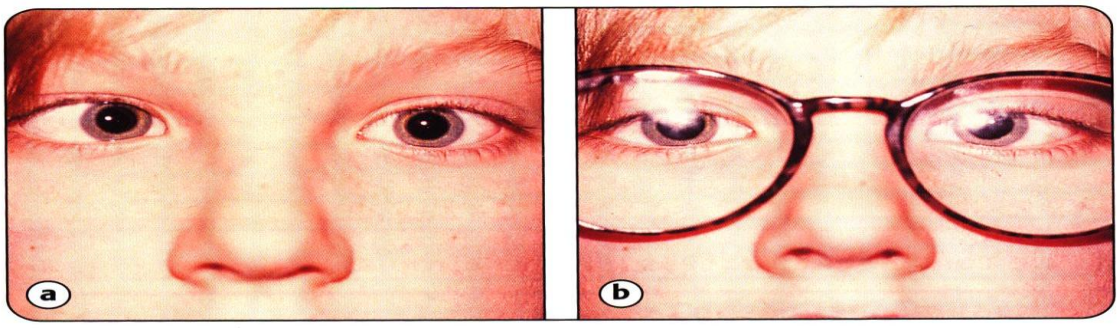
علاج حالات الحول

١- تصحيح الخطأ ألانكساري الموجود تصحيحا كاملا .

٢- اعاقة العين القوية عن العمل بتغطيتها بهدف اجبار العين الضعيفة على العمل .

٣- التمرينات على اجهزة خاصة لغرض ادماج الصورتين إلى صورة واحدة .

٤- عمليات الحول الجراحي على العضلات المحركة للعين وقد تحتاج العين لأكثر من عملية او قد تستعمل اكثر من طرقة من هذه الطرق او استعماله جميعا.



ملاحظة مايلي من قبل الملاكات العاملة في مراكز الرعاية الصحية الاولية:-

- ملاحظة صفاء القرنية الذي يفقد عند وجود تخدش او تقرح .
- ملاحظة البؤبؤين من حيث الحجم والشكل والتفاعل مع الضوء اذ يكون البؤبؤ متوسع ولايتفاعل مع الضوء في داء الزرقاء الحاد وقد يكون متقلصا في التهاب القزحية.
- ملاحظة نوع الافراز اذ يكون قيحيا في التهاب المنظمة القيحي ومائيا في حساسيات العين والتهاب القزحية .
- وجود جرح واضح في القرنية او المنظمة .
- ملاحظة الاجفان في حالة هطول الجفن او تساقط الرموش
- قلب الاجفان وملاحظة وجود حبيبات في الاجفان كما في بعض الامراض المصاحبة للحساسية او التراخوما ان وجدت مع ملاحظة وجود جسم غريب على قرنية العين او منظمة العين.
- ملاحظة وجود تضخم في الغدد اللمفاوية امام صيوان الاذن كما في بعض التهابات المنظمة الفايروسي وعند اصابة العين بالسيلان وخاصة في الاطفال حديثي الولادة
- الاستفسار من المريض عن بعض الاعراض مثل الالم الشديد في حالة داء الزرقاء الحاد والتهاب القزحية والتقيؤ في داء الزرقاء الحاد او الحكة الشديدة في حالة حساسية العين او هبوط الرؤية .
- اكتشاف ومعالجة حالات التراخوما (ان وجدت) بين الطلاب .وذلك بقلب الجفن لملاحظة وجود حبيبات او تليفات في الجفن او وجود اوعية دموية جديدة او تليفات في القرنية بعد تسليط مصدر ضوئي الى العين مع استعمال عدسة مكبرة

- يجب قياس حدة البصر لطلاب المدارس باستعمال لوحة فحص البصر للطلبة الجدد واحالة الطلاب ضعيفي البصر لغرض تصحيح الاخطاء الانكسارية ومعالجة كسل العين Amblyopic ان وجدت
- ملاحظة وجود حول واضح او رأرأة لدى الطلاب واحالتهم لغرض العلاج .
- اكتشاف حالات الحول واختلال عضلات العين.
- فحص حدة البصر باستخدام لوحة سنيلن Snellen Chart . فهبوط الرؤية قد يتسبب عن الساد (Cataract)او داء الزرقاء (Glaucoma) او اعتلال الشبكية السكري او نتيجة اخطاء انكسارية..
- ملاحظة انعكاس الضوء من قاع العين (red reflex) باستعمال الناظور اذ يلاحظ ابيضاض البؤبؤ في حالات الساد و ملاحظة البؤبؤين من حيث الشكل والتفاعل مع الضوء اذ يكون البؤبؤ متوسع ولايتفاعل مع الضوء في حالات الزرقاء الحاد .
- الفحص (بالناظور الشبكي RetinoScope) او(Autorefractometer) ويقوم به فاحصي البصر لتحديد الخطأ الانكساري وتصحيحه بالعدسات الملائمة ووصف النظارات الطبية الملائمة من قبل وتدريب المريض على كيفية استخدامها والعناية بها واكتشاف حالات الحول ومعالجتها بغلق العين والنظارات الطبية .
- توفير فيتامين A لطلاب المدارس .

- تحصين الأطفال بلقاح الحصبة و متابعة اجراء تلقيحات الحصبة الالمانية للاناث قبل مرحلة الدراسة المتوسطة لما يسببه هذا المرض من امراض ولادية وتشوهات تصيب العين كالساد الولادي وداء الزرقاء الولادي وغيرها
- تدريب المعلمين في المدارس الابتدائية ورياض الاطفال على قياس حدة البصر لاكتشاف حالات ضعف البصر لدى الطلاب واحالتهم الى المستشفيات

تعليمات قد تساعد في تقليل إصابات عيون الأطفال:

١ – امنع الأطفال من اللعب أو المزاح بالزجاجات المقفلة.

٢ – ابعد فوهة الزجاجة عن الوجه والعينين عند فتحها.

٣ – تذكر أن الزجاجات البلاستيكية أو العلب أكثر سلامة للأطفال من العبوات الزجاجية.

٤ – ضع الزجاجات في الثلاجة وليس في الفريزر حيث يحب الأطفال اللعب بزجاجات المشروبات الغازية ورجها، وبما أن زجاجات المشروبات الغازية تم تعبئتها وإقفالها تحت ضغط يمكن للزجاجة تحمله في درجات الحرارة الطبيعية، لذا فإن رج الزجاجة بخاصة عندما يكون المشروب ساخناً يتسبب في رفع الضغط داخل الزجاجة وانفجارها، كذلك فإن الزجاجات التي توضع في "الفريزر" لتبرد بسرعة يمكن أن تتعرض للانفجار. .

٥ – اختر لهم الألعاب المأمونة التي تناسب عمرهم ويمكن اللعب بها بأمان، وتجنب شراء الألعاب القاذفة لهم مثل؛ القوس والسهم والتي يمكن أن تنطلق إلى أو تصيب العين من مسافة بعيدة.

٦ – قم بالإشراف على الأطفال أثناء لعبهم وعلمهم الأنشطة المأمونة، فالتراشق بالحجارة والحصى أثناء اللعب قد يؤدي إلى إصابات خطيرة كان من الممكن تجنبها.

٧ – احفظ مواد التنظيف والمواد المطهرة والكيماوية في مكان آمن وبعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

٨ – علم أطفالك الطريقة الصحيحة لحمل الأشياء التي يمكن أن تشكل مصدراً للخطر، وعلمهم أيضاً تجنب الركض إذا ما كانوا يحملون أدوات جارحة أو حادة.

٩ – لا تسمح لأطفالك اللعب بالألعاب النارية إذ إنها قد تشكل خطراً عليهم.حيث يكثر لهو الأطفال بالألعاب النارية المختلفة في الأعياد والمناسبات، أو إطلاقها أحيانا من قبل الكبار، وقد يتسبب ذلك في الكثير من الإصابات نتيجة لقذفها أو انفجارها.

١٠ – ابعد الأطفال عن أدوات المطبخ التي يمكن أن تشكل خطراً عليهم .

١١ – علم أطفالك كيفية المحافظة على حماية أعينهم وذلك باستعمال النظارات الشمسية بشكل روتيني عند الخروج من المنزل، كما عليك أن تمنعهم من النظر إلى الشمس مباشرة وبخاصة أثناء الكسوف.



التوعية الصحية

- توعية الاباء والامهات الى عدم شراء لعب اطفال ذات السطوح والحافات المدببة والحادة لاطفالهم ومنع الابناء من استعمال بنادق الصيد والمسدسات التي تحوي على اشعة الليزر .
- توعية السواق لاستعمال احزمة الامان عند قيادة السيارة .
- استعمال النظارات الواقية عند قيادة الدراجات النارية .
- توعية العمال في المصانع والمعامل الاهلية الى استخدام النظارات الواقية خصوصا عند اللحام واتباع شروط الامان في المصانع وتوفير الاضاءة الملائمة وكيفية التعامل مع الاصابات العينية في المعامل .

– استخدام وسائل الايضاح كالبوسترات في المدارس والمعامل والافلام القصيرة في التلفزيون التي توضح مختلف الامراض والاصابات العينية التي تؤدي الى العمى .. وكيفية التعامل معها .

- اعطاء التوجيهات للام الحامل من ناحية التغذية وتغذية طفلها لمنع اصابة الطفل بنقص فيتامين (A) الذي يسبب تقرحات وندب القرنية (Corneal Scars) التي قد تؤدي الى العمى بالاضافة الى ذلك ان النساء الحوامل والمرضعات المصابات بنقص فيتامين A يسبب خلل في الجهاز المناعي وزيادة فرص الوفاة لدى الاطفال بحوالي ٢٠% .
- تشجيع الرضاعة الطبيعية ، لان حليب الام غني بفيتامين A .
- تناول الوجبات الغذائية الغنية بفيتامين A .
- التلقيح ضد الحصبة يمنع اصبة العين بتقرحات القرنية .



المصادر :

-VISION 2020 THE RIGHT TO التعريف ببرنامج- VISION2020 World Sight Day Report 2008 SIGHT

- Editor: Graham /A Manual for VISION 2020: The Right to Sight Workshops - Dye/Publisher: The International Centre for Eye Health/Date: 2005

- Where There Is No Doctor 2013 عندما لا يوجد الطبيب

- The Healthy Eyes Activity Book

A Health Teaching Book for Primary Schools, 2nd Edition

By Victoria Francis and Boateng Wiafe.

International centre for eye health , SIGHT AND LIFE.

- العمل على توفير صحة العين للجميع (خطة عمل عالمية للفترة من ٢٠١٤-٢٠١٩)
- ضمان جودة الرعاية العينية الاولية معلومات اساسية
- خطة العمل المحلية لمشروع فحص عين الطفل قبل سن المدرسة /شعبة الصحة العينية والوقاية من العمى/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية